

ENDOMÉTRIOSE

ADÉNOMYOSE

SMOP

(SYNDROME MÉTABOLIQUE OVARIEN POLYENDOCRINIEN)



MON CARNET EXPLICATIF

**(symptômes, diagnostic, origines, traitements,
enjeux psychologiques, sociaux et financier)**

PETITS POINTS TECHNIQUE SUR L'ENDOMÉTRIOSE, L'ADÉNOMYOSE ET LE SMOP...

● L'ENDOMÉTRIOSE,

se caractérise par la présence de cellules semblables à de l'endomètre se développant en dehors de l'utérus.

Ces dernières réagissent aux variations hormonales du cycle menstruel comme le ferait l'endomètre, et entraînent généralement l'apparition de lésions, d'adhérences ou de kystes.

Les douleurs engendrées, bien que pouvant être présentes à n'importe quel moment du cycle, sont donc tout particulièrement intenses lors des périodes de règles.

Elles sont souvent décrites par les patient.e.s par des termes divers comme par exemple des piqures d'aiguilles, des coups de poignards, des brûlures, des décharges électriques, des sensations de lourdeur, de fils barbelés, de tiraillements, de déchirements etc

On classifie l'endométriose sous trois différentes formes :

ovarienne (situé sur les ovaires), superficielle (péritonéale) et pelvienne-profonde (sous-péritonéale).

Il n'y'a pas de corrélations entre l'intensité des douleurs et le type d'endométriose, une endométriose même superficielle peut donc être particulièrement douloureuse.

Les tissus endométriosiques peuvent s'implanter sur divers organes comme par exemple les ovaires, les trompes, le péritoine, la vessie, les ligaments utéro-sacrés, les intestins, le diaphragme, les poumons, et même dans certains cas, rares mais néanmoins possible, au niveau du cerveau ...

... ET OUI !

Contrairement à certaines idées reçus l'endométriose n'est pas une maladie "gynécologique" au sens strict du terme ...
il s'agit en réalité d'une maladie :

CHRONIQUE

car c'est une pathologie qui s'installe et dure dans le temps.
Elle ne guérit pas spontanément et peut persister, évoluer ou fluctuer tout au long de la vie des personnes atteintes.

SYSTÉMIQUE

car comme précisé ci-dessus, elle ne se limite pas à la sphère gynécologique puisqu'elle peut toucher l'ensemble du corps nécessitant alors de se tourner vers divers spécialistes en fonction des zones touchées.

INFLAMMATOIRE

car les lésions d'endométriose provoquent une réaction inflammatoire dans les tissus où elle se trouve ainsi qu'aux alentours.

C'est d'ailleurs cette inflammation qui est bien souvent à l'origine de nombreux symptômes comme les douleurs chroniques, les troubles digestif et/ou urinaire, la fatigue chronique ...
d'où l'importance d'adapter son hygiène de vie d'une façon globale (alimentation, gestion du stress ...)

Bien que les symptômes lui étant associés les plus connus soient

les douleurs de règles ou l'infertilité,

elle est également à l'origine de tout un tas d'autres douleurs et dysfonctionnement

différents selon les patient.e.s, les zones touchées, la gravité des atteintes,

le niveau d'inflammation ou le moment du cycle :

Endobelly (ventre gonflé et douloureux), dyspareunie (douleurs pendant/après les rapports intimes),
fatigue chronique, règles abondantes, troubles du système digestif et/ou urinaire, douleurs rectale,
douleurs neuropathiques, douleurs lombo-dorsales, difficultés à marcher, douleurs temporo-mandibulaires,
douleurs à l'épaule, douleurs thoraciques, essoufflements, pneumothorax,
nausées, vertiges, migraines, vision flou, crises d'épilepsies, hypersensibilité corporelle ou auditive,
douleurs dentaires, difficultés de concentration et confusion mentale, saignement ombilicaux
... et bien d'autres ...

Les symptômes peuvent se présenter de façon séparées ou au contraire en même temps,

de façon ponctuelles, intermittentes, constantes et/ou plus ou moins permanentes,

et cela pendant ou en dehors de la phase menstruelle (règles).

Évidemment certains sont plus courants que d'autres,

de même que certaines formes d'endométrioses sont rare voir extrêmement rare.

Néanmoins, il est intéressant et important de les connaître afin de pouvoir les identifier,

la rareté n'excluant pas la possibilité !

● L'ADÉNOMYOSE ,

quant à elle , est souvent présentée comme étant une forme particulière d'endométriose interne
puisque'elles ont en commun plusieurs symptômes et mode de fonctionnements .

Cependant elle est tout de même considérée comme une pathologie à part entière .

Contrairement à l'endométriose ,

elle ne peut toucher que le muscle utérin (myomètre)

et se manifeste lorsque du tissu endométrial s'infiltré dans ce muscle ,

provoquant alors parfois comme pour l'endométriose

des douleurs menstruelles intenses, et des douleurs pendant les rapports (dyspareunies),

A ces symptômes peuvent s'ajouter également des règles abondantes (ménorragies),

avec une quantité de sang perdu indépendantes de l'intensité des douleurs,

mais qui peut alors entraîner une carence en fer, voire une anémie. (risques multipliés par 5)

Elle peut également être à l'origine de troubles de la fertilité

puisque'elle modifie la capacité de l'utérus à faciliter

la fécondation et à accueillir l'implantation embryonnaire.

Plusieurs études ont d'ailleurs montré que l'adénomyose réduisait les chances de grossesse,

cela y compris avec la fécondation in vitro (FIV).

● LE SYNDROME MÉTABOLIQUE OVARIEN POLY-ENDOCRINIEN (SMOP, ANCIENNEMENT SOPK) ...

... est un trouble du système hormonal et métabolique global.

Le terme « Polyendocrinien »

fait référence aux multiples systèmes hormonaux impliqués .

Le terme « Métabolique »

souligne le risque permanent de diabète et de maladies cardiaques .

Le terme « Ovarien »

maintient le lien avec les troubles de l'ovulation et l'infertilité,
qui restent des caractéristiques essentielles de cette maladie.

Auparavant appelé syndrome des ovaire polykystique (SOPK),
sa dénomination a changé car elle ne correspondait pas complètement à la réalité clinique de la pathologie
La nouvelle appellation vise donc à refléter la réalité multisystémique de l'affection
dans l'objectif de mieux la repérer et de mieux la prendre en charge.

On estime à environs 170 millions le nombre de personnes atteintes à travers le monde.
Les troubles endocriniens sont fréquents et multiples, pouvant toucher la régulation de l'insuline,
des androgènes, des hormones ovariennes et neuroendocriniennes.

Les conséquences peuvent être :

- **métaboliques** : diabète de type 2, prise de poids,
difficulté à en perdre voir obésité, maladie cardiovasculaire
- **Psychologiques** : dépression, anxiété, altération de la qualité de vie,
troubles du comportement alimentaire (TCA)
- **dermatologiques** : acné, alopecie, hirsutisme.
- **Reproductives** : dysfonction ovulatoire, cycles menstruels irréguliers, infertilité,
complications de la grossesse et cancer de l'endomètre

Son diagnostic repose sur un bilan sanguin, une échographie abdominopelvienne
ainsi que sur les critères de Rotterdam, qui associent au moins deux des trois éléments suivants :

- Des cycles irréguliers ou une absence de règles (anovulation ou dysovulation).
- Une hyperandrogénie clinique ou biologique : excès d'hormones masculines (testostérone),
se traduisant par de l'acné, une pilosité excessive (hirsutisme) ou une alopecie.
- un aspect échographique des ovaires avec de nombreux follicules immatures

Ces trois pathologies peuvent coexister

mais aussi

être présentes indépendamment l'une de l'autre.

Elles peuvent toucher n'importe quelle personne née avec un utérus, menstrué.e ou pas.

Cela peu importe son âge : adolescentes, adulte ou personne ménopausée,

mais également peu importe son identité de genre :

femmes cisgenres , personnes trans, non-binaires ou intersexes.

● Concernant les origines de ces pathologies ...

... de nombreuses pistes et théories existent, sont étudiées ou reste encore à explorer.

Elles pourraient être multifactorielles :

Mécaniques (théorie du reflux) , hormonales, immunitaires, génétiques, environnementales
certains liens ont même été fait avec les troubles neuroatypiques !

Malheureusement à ce jour, il est difficile d'affirmer avec certitude les raisons de leurs apparitions.

● Il n'existe, pour le moment, pas de traitement curatif ...

... Les traitements actuels visent donc plutôt à soulager les douleurs, les divers symptômes, améliorer la qualité de vie des patient.e.s et limiter la progression des lésions en fonction de chaque patient.es.

Parmi les solutions proposées par le milieu médical on retrouve notamment les traitements hormonaux (pillule contraceptive, ménopause artificielle) la prise en charge médicamenteuse de la douleur (AINS, antalgiques, TENS), ou certaines interventions chirurgicales (coelioscopie, laparoscopie, hystérectomie ...).

Dans le cas où ces pathologies auraient un impact sur la fertilité et provoqueraient des difficulté à concevoir, les patient.es peuvent également se voir proposer la congélation d'ovocytes ainsi que l'aide médicale à la procréation (PMA) ou la fécondation in-vitro (FIV)

Mais il existe aussi d'autres possibilités paramédicales et dites de "médecines alternatives" comme la kinésithérapie, l'ostéopathie, l'acupuncture, l'auriculothérapie, la sophrologie, les activités physiques douces type yoga, la micro-nutrition, la diététique, la naturopathie, la thérapie cognitive comportementale, la méditation et bien d'autres, qui peuvent également être un complément aux solutions médicales plus classiques et peuvent aider à minimiser voir soulager certaines douleurs et certains symptômes ainsi qu'à mieux tolérer certains potentiels effets secondaires des traitements médicaux.

Évidemment toutes les solutions proposées et citées ci-dessus, qu'elles soient médicales, paramédicales ou dites de "médecines alternatives", comportent leurs limites, leurs lots de contraintes, d'effets secondaires et/ou de risques, et ne sont pas forcément toujours adaptées à chacun.e.s ni même toujours efficace d'un.e patient.e à un.e autre.

Il est donc important d'être suivit par des professionnel.le.s compétent.e.s et spécialisé.e.s mais aussi de s'informer soi-même sur chacune de ces pratiques, tout en gardant évidemment à l'esprit qu'un corps n'appartient qu'à soi et qu'il revient donc à chaque patient.es le droit d'accepter certains traitements et d'en refuser d'autres, mais également de changer d'avis à tout moment de leur prise en charge.

Il faudra souvent en essayer plusieurs avant de trouver ce qui fonctionne pour soi.

À noter également que, contrairement à certaines idées reçues, validées et conseillées par certain.e.s professionnel.le.s de santé mal formé.e.s et mal informé.e.s, concevoir un enfant n'est pas une solution ou un moyens de faire disparaître les douleurs, les symptômes et les pathologies.
Ces derniers persistent parfois même, pendant et après la grossesse.

● Côté diagnostic et reconnaissance ...

... en France, il faut en moyenne 7 années d'érance médicale pour arriver à un diagnostic, parfois plus, même si ce délais devrait tendre à se raccourcir à l'avenir grâce au travail de communication et d'information de diverses associations et à la mise en place de stratégies nationales comme celle de la lutte contre l'endométriose afin de mieux former le personnel médical.

Le diagnostic repose principalement sur les symptômes exprimés par les patient.e.s, et l'imagerie médicale (échographie, IRM) et/ou l'exploration chirurgicale (coelioscopie).

Mais attention, concernant l'endométriose et l'adénomyose il faut savoir que les imageries négatives ne signifient pas nécessairement qu'il n'y'a pas d'atteintes. Certaines lésions sont difficilement ou non-décelables malgré leur présences, on parle alors de discordance clinico-radiologique.

L'endométriose, l'adénomyose et le SMOP ne sont toujours pas reconnue comme affection longue durée (ALD), en revanche, il est possible d'obtenir, sous certaines conditions, une ALD 31 (ALD "hors liste"), ainsi que l'allocation adulte handicapé (AAH), une reconnaissance de qualité travailleur handicapé (RQTH) ou bien une carte mobilité et inclusion (CMI)

Mais il est important de souligner que les modalités d'obtentions de ces reconnaissances ne sont, malheureusement, pas toujours en adéquation avec la réalité de vie des patient.e.s. et un grand nombre se les voient refuser malgré des symptômes difficiles et/ou invalidants ...

● Ces délais et ce manque de reconnaissance sont dûent au fait que ...

... bien qu'elles touchent des millions de personnes dans le monde (1 personne né.e avec un utérus sur 10) ces pathologies ne sont véritablement prises en compte par la recherche, le corps médical et le système de santé que depuis très peu de temps.

Ce retard est principalement dû au fait que nos société et notre système de santé se sont construits sur un modèle médical androcentré.

En effet, le corps des personnes assignées homme à la naissance est depuis bien longtemps considéré comme étant la norme, celui des personnes assignée femme à la naissance et dotées d'un utérus étant quant à lui considéré comme un simple dérivé plus instable et moins fiable puisque soumis à des variations hormonales plus complexes.

À noté également que même si cela tend à s'améliorer, encore à notre époque, la majorité des traitements médicamenteux sont testés majoritairement sur des sujets dits "mâles".

Les cycles hormonaux des personnes dotées d'un utérus étant encore considérés comme des perturbateurs faussant les résultats ou complexifiant leurs obtentions ...

Il en résulte donc que la moitié de la population mondiale reçoit donc par conséquent des traitements non adaptés à sa physiologie

En dehors des questions liées à la fertilité, et comme mentionné précédemment, les spécificités physiologiques, hormonales et symptomatiques propres aux personnes nées avec un utérus ont été trop peu étudiées, reléguées au second plan voire totalement ignorées.

Cette invisibilisation a conduit à des retards considérables dans la compréhension, le diagnostic et le traitement de nombreuses pathologies qui les touchent.

Les patient.es se retrouvent donc régulièrement confronté.e.s aux conséquences de ce mode de fonctionnement ...

... non seulement avant leur diagnostic :

" C'est normal d'avoir des douleurs pendant vos règles / c'est dans votre tête /
vous êtes juste un peu douillet.te / c'est juste un peu de stress /
vous êtes sûr.e que vous n'exagérez pas un peu ? /
vous êtes trop jeune pour avoir de l'endométriose / vous n'avez qu'à faire plus de sport /...

... et même après leur diagnostic :

" C'est juste la maladie à la mode ! / ce n'est pas comme si c'était une vraie pathologie /
il vous suffit de prendre la pilule et tous vos problèmes seront résolus /
vous n'avez qu'à faire des enfants / on n'en meurt pas /
tu t'écoutes trop / T'abuses, tu annules toujours au dernier moment /
des troubles digestifs liés à votre endométriose? c'est sûr que ça n'a rien à voir,
y'a plus de chance que ce soit une allergie alimentaire /
Un certificat médical pour vos cours? et puis quoi encore, prenez un Doliprane" ...

Ces négations et/ou minimisations sont d'ailleurs exprimées, non seulement par certains soignants, mais également, bien souvent par l'entourage personnel, professionnel ou scolaire des personnes touché.e.s.

Pour les personnes trans, non-binaires, intersexes et/ou racisées tout cela est également une réalité.

Leur parcours est souvent d'autant plus compliqué puisqu'iels sont également
souvent invisibilisé.es et/ou stigmatisé.es dans le milieu médical
et doivent parfois faire face à des expériences de discriminations diverses.

(refus de consultation, commentaires déplacés, homophobie,
remise en question de l'identité de genre, syndrome méditerranéen ...)

Ce type d'expériences, vécues généralement
chez certain.s médecins ou praticien.ne.s non-formés ou mal informés sur le sujet,
peuvent transformer le parcours des patient.es, déjà difficile,
en véritable parcours du combattant.

Il est donc important, afin d'obtenir une prise en charge sérieuse et bienveillante,
de se rapprocher de professionnel.le.s spécialisé.e.s formé.e.s sur ces pathologies.

Si vous êtes victime ou confronté.e à des violences d'ordre physiques,
gynécologiques, médicales, sexuelles, psychologiques, verbales ou discriminatoires,
vous pouvez vous tourner vers des associations et des structures spécialisées
qui pourront vous accompagner, vous écouter et vous orienter au mieux.

● Ces pathologies ont des conséquences sur tous les pans de vie des personnes touchées ...

... que ce soit dans la sphère sociale, intime, professionnelle, ou même financière.

Au delà des difficultés physiques, l'endométriose, l'adénomyose et le SMOP
représentent souvent une véritable charge mentale non-négligeable et épuisante :

› Errance médicale

› Difficultés à être pris.e.s au sérieux, écouté.e.s par certains soignants , et cela même après diagnostic.

› Maltraitements médicaux et obstétricaux, minimisation des symptômes .

› Discriminations (transphobie, racisme, sexisme, grossophobie...)

› Difficultés pour obtenir des rendez-vous avec des spécialistes

› Absences répétées en cours, risque d'échec scolaire.

› Absences répétées au travail engendrant une perte financière.

› incompréhension et reproches des collègues ou de la direction.

› Moins d'opportunités d'évolution en entreprise.

› Difficultés à garder ou trouver un emploi.

› Plus de chance d'appartenir à une catégorie dites précaire

et/ou socio-professionnelles inférieure aux personnes non touchées

› Difficultés pour obtenir des aides et prestations par la MDPH ainsi qu'une reconnaissance de sa maladie .

› Frustration de voir sa demande MDPH refusée malgré des symptômes réellement invalidants.

› Coût de certains produits ou soins que l'on ne peut pas toujours se permettre car non remboursés.

› Rendez-vous personnels, médicaux, ou professionnels annulés souvent au derniers moments.

› Evénements importants manqués.

› Difficultés à s'engager dans des projets car difficile de prévoir à l'avance les épisodes de crises.

› Difficultés à concevoir des enfants ou au contraire injonction à la maternité.

› Incompréhension de l'entourage et de la population en général.

› Impact sur le couple et l'intimité.

› Traumatismes liés au vécu de certaines crises et appréhension des crises à venir.

› Gestion du changement d'hygiène de vie parfois pesant et frustrant

› Deuil de la personne qu'on était avant l'apparition des pathologies et des symptômes

› Abandon de projets et de rêves car non compatible avec les pathologies.

.....

Tout cela peut faire naître chez les patient.e.s un sentiment de culpabilité et d'impuissance,
engendrant souvent à terme de véritables difficultés, souffrances psychologiques, émotionnelles,
et provoquant même parfois une perte de confiance du milieu médical.

Cela peut aussi entraîner l'apparition de troubles anxieux,
de troubles du comportement alimentaire (TCA) ou même des cas de dépressions.

Cet impact psychologique et émotionnel a lui aussi

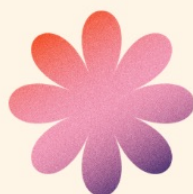
un impact direct sur la réponse immunitaire et inflammatoire du corps,

les patient.e.s se retrouvant alors dans un cercle vicieux et sans fin de douleurs et d'épisodes symptomatiques.

● Pour conclure ...

... L'endométriose, l'adénomyose, et le S.M.O.P
sont des pathologies chroniques, systémiques
qui impactent de manière plus ou moins importante la qualité de vie des personnes atteintes
dans sa globalité et qui répondent à des facteurs divers et multiples.

Il est par conséquent important et nécessaire de questionner
plusieurs aspect de la vie des patient.e.s et d'obtenir
une prise en charge multidisciplinaire, globale, sérieuse et surtout bienveillante !!!



● L'OUTIL CARNET ●

Dans un premier temps ...
il peut être un moyen simple pour t'aider à mieux comprendre
et à mieux gérer la vie avec ces pathologies souvent complexes et fluctuantes.

En notant régulièrement tes symptômes, tes douleurs, leur intensités,
ainsi que les facteurs pouvant les influencer,
tu pourras ainsi constater :

- les évolutions, positives ou négatives, de ta/tes pathologie.s sur le long terme,
 - Observer l'efficacité des soins et traitements mis en place
 - L'impact réel qu'on les pathologies sur ta vie professionnelle/scolaire et tes finances.
- mais aussi

apprendre et mieux comprendre comment fonctionne ton cycle hormonal et te le ré-approprier.

Dans un second temps ...
il pourra devenir un outil précieux dans le cadre de tes consultations
médicales, paramédicales ou dites de " médecines alternatives",
permettant de fournir un historique précis et détaillé,
et aidant ainsi les professionnel.le.s de santé à comprendre ton parcours
afin d'affiner leur diagnostic et d'adapter ta prise en charge.

